



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PENGELOLAAN PENGADUAN PASIEN DAN
KELUARGA**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 319.32/I-PDM/IGD/IV/2025

Tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pengaduan Pasien dan Keluarga

Disusun oleh :
Penanggung Jawab TIM AKP



(Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman. Pengelolaan Pengaduan Pasien dan Keluarga dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada. Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pasien dan Keluarga ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi organisasi, wewenang dan tanggung jawab penanganan pengaduan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman. Pengelolaan Pengaduan Pasien dan Keluarga ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 04 April 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PASIEN DAN KELUARGA

Pengarah :

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

Pelaksana :

1. dr. Nur Mazidah
2. Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns
3. Ratih Aji Suryamanjari, S.Kep., Ns
4. Murwani Suryaning Sapartinah, A.Md. Kep
5. Ferianto Hendri Cahyono, AMd. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR..... ii

TIM PENYUSUNiii

DAFTAR ISI..... iv

PERATURAN DIREKTUR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 2

 1.3 Ruang Lingkup 2

 1.4 Pengertian 2

BAB II ORGANISASI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENANGANAN

 PENGADUAN..... 3

 2.1 Pengorganisasian 3

 2.2 Wewenang dan Tanggung Jawab..... 3

BAB III TATA LAKSANA PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN..... 5

 3.1 Penanganan Pengaduan Pelayanan Pada Jam Kerja 5

BAB IV PENUTUP 13

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA**

NOMOR: 319.32/I-PDM/IGD/IV/2025

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PASIEN DAN
KELUARGA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang :
- a. bahwa pengaduan pasien dan keluarga merupakan salah satu bentuk peran serta pasien dan keluarga dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 (tentang Standarisasi Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malangxx-['/f v v
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PASIEN
DANKELUARGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Sistem pengaduan pelayanan di unit pelayanan dilaksanakan secara konsisten dalam menghadapi keluhan, konflik, atau beda pendapat.
- (2) Pasien diberitahu tentang proses menyampaikan keluhan, konflik,



atau perbedaan pendapat.

- (3) Keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat ditelaah serta ditindaklanjuti oleh rumah sakit serta didokumentasikan.
- (4) Pasien dan atau keluarga pasien ikut serta dalam proses penyelesaian.

BAB II

PENGELOLAAN PENGADUAN PASIEN DAN KELUARGA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan pengaduan pasien dan keluarga ditanggapi sesegera mungkin sejak pengaduan diterima, maksimal 1x24 jam.
- (2) Pengelolaan pengaduan meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan lebih lanjut, pelaporan, dan pengarsipan.
- (3) Pengelolaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa tanggapan secara langsung melalui klarifikasi atau memberi jawaban, dan penyaluran / penerusan kepada unit terkait yang berwenang menangani.
- (4) Pengaduan pelayanan di unit pelayanan telah sesuai dengan regulasi

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 04 April 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR 319.32/I-PDM/IGD/IV/2025
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGADUAN PASIEN DAN KELUARGA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat sekarang ini pasien dan keluarga sudah semakin cermat dan kritis terhadap produk jasa yang diperolehnya termasuk pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan. Hal ini tentunya memacu instansi rumah sakit khususnya rumah sakit swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanannya mulai dari pra sampai pasca pelayanan. Pelayanan yang prima akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit tersebut.

Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit). Sedangkan pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum perjanjian terapeutik dengan pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Melalui mottonya, Sahabat Menuju Sehat, RS Prima Husada berkomitmen untuk memberikan pelayanan medis yang terbaik kepada pasien dan keluarga, memberikan penjelasan medis yang komprehensif kepada seluruh pasien dan menjunjung tinggi keselamatan pasien serta hak dan kewajiban pasien.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan pasien dan keluarga akan pelayanan yang lebih baik, pelayanan kesehatan dituntut untuk lebih berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan terbaik sehingga pasien merasa aman dan nyaman selama menjalankan proses perawatan kesehatan.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit, tentunya tidak bisa terlepas dari adanya pengaduan yang terjadi antara pasien dan rumah sakit. Pengaduan merupakan pernyataan atau tindakan yang dilakukan oleh pelanggan terhadap orang atau unit atau organisasi yang menghasilkan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan tersebut. Meningkatnya kesadaran hukum pasien dan keluarga secara langsung mendorong pasien dan keluarga untuk menuntut haknya sebagai pasien dalam menerima pelayanan kesehatan.

Di dalam Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan telah diatur tentang hak dan kewajiban penerima dan pemberi jasa pelayanan kesehatan yang diharapkan dalam penerapannya dilaksanakan secara berimbang. Dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit,

kemungkinan muncul atau timbulnya tuntutan hukum baik tuntutan pidana, gugatan perdata maupun administrasi terhadap petugas atau pelaksana professional dan manajemen sangat besar. Oleh karena itu pengaduan harus diselesaikan secepat mungkin sehingga hubungan antara pasien dengan rumah sakit dapat terjalin dengan baik dan tidak terjadi konflik yang serius sehingga kepuasan pasien dapat tercapai.

Pasien mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan tentang pelayanan yang mereka terima. Keluhan tersebut dicatat, ditelaah, di tindaklanjuti, dan dicari penyelesaiannya bila memungkinkan. Demikian pula, bila keputusan mengenai pelayanan menimbulkan pertanyaan, konflik, atau dilema lain bagi rumah sakit dan pasien, keluarga atau pembuat keputusan, dan lainnya. Dilema ini dapat timbul dari masalah akses, etis, pengobatan atau pemulangan pasien, dsb.

Rumah sakit menetapkan cara-cara dalam mencari solusi terhadap dilema dan keluhan tersebut. Rumah sakit mengidentifikasi dalam regulasi, siapa yang perlu dilibatkan dalam proses, serta bagaimana pasien dan keluarganya berpartisipasi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Setelah membaca pedoman ini, diharapkan mampu memahami bagaimana cara penanganan pengaduan sehingga semua pengaduan dari pasien bisa diselesaikan secara profesional dan kekeluargaan serta tercapainya kepuasan pasien.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pengaduan pelayanan pasien dan keluarga meliputi:

1. Pengaduan pasien dan keluarga,
2. Penanganan pengaduan pasien dan keluarga,
3. Pelaporan dan pemantauan

1.4 Pengertian

1. Pengaduan pasien dan keluarga adalah bentuk pengawasan pasien dan keluarga yang disampaikan oleh pasien dan keluarga kepada rumah sakit, berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
2. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pasien dan Keluarga yang adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.
3. Pelapor adalah individu atau kelompok pasien dan keluarga yang menyampaikan pengaduan kepada rumah sakit.
4. Terlapor adalah staf atau kelompok pasien dan keluarga yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
5. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang dilaporkan/diadukan;
6. Klarifikasi adalah proses penjernihan masalah atau kegiatan yang memberikan penjelasan/data/dokumen/bukti-bukti mengenai permasalahan yang diajukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait;
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai kebenaran atas pengaduan pasien dan keluarga.

BAB II

ORGANISASI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENANGANAN PENGADUAN

2.1 PENGORGANISASIAN

Penyelesaian penanganan pengaduan di rumah sakit merupakan tanggung jawab manajemen rumah sakit.

Penanganan pengaduan pelayanan non medis di rumah sakit melibatkan unit-unit kerja atau pihak-pihak terkait yang meliputi:

1. Penanganan pengaduan pelayanan non medis di rumah sakit dilakukan oleh:
 - a. Customer Service
 - b. Unit/Instalasi terkait
Manajemen (Asisten Manajer Pelayanan Medis dan Manajer On Duty Rawat Jalandan Rawat Inap)
2. Penanganan pengaduan pelayanan medis di rumah sakit dilakukan oleh:
 - a. Customer Service
 - b. Komite Medik didampingi manajemen (Asisten Manajer Pelayanan Medis dan Manajer On Duty Rawat Jalan dan Rawat Inap)
 - c. Unit/Instalasi terkait

2.2 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Manajemen Rumah Sakit
 - a. Wewenang
 - 1) Bertindak untuk dan atas nama rumah sakit.
 - 2) Mengarahkan / menginstruksikan satuan kerja terkait dalam penyelesaian pengaduan.
 - 3) Memberdayakan potensi dalam upaya penyelesaian penanganan pengaduan.
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Menyelesaikan penanganan pengaduan di rumah sakit.
 - 2) Mengambil langkah strategis baik eksternal maupun internal dalam pengaduan pelayanan medis dan non medis.
 - 3) Mengamankan dokumen dan informasi penanganan kasus hukum pelayanan medis dan non medis.
 - 4) Melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya penanganan kasus hukum pelayanan medis dan non medis.
 - 5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *clinical governance*.
 - 6) Menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelesaian penanganan kasus hukum pelayanan medis dan non medis.
 - 7) Melakukan pembinaan terhadap tenaga medis dan non medis.
 - 8) Melakukan advokasi kepada tenaga kesehatan yang diduga terkait penanganan kasus hukum pelayanan medis.
2. Customer Service
 - a. Wewenang

-
- 1) Bertindak untuk dan atas nama rumah sakit.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyelesaian pengaduan.

b. Tanggung Jawab

- 1) Menyelesaikan penanganan pengaduan di rumah sakit.
- 2) Mengambil langkah strategis secara internal dalam penanganan pengaduan pelayanan non medis.
- 3) Mengamankan dokumen dan informasi penanganan pengaduan pelayanan non medis.
- 4) Melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya penanganan kasus hukum pelayanan medis dan non medis.

3. Komite Medik

a. Wewenang

- 1) Membuat kebijakan yang tertuang di dalam *medical staf by laws*.
- 2) Melakukan kredensial terhadap tenaga medis.
- 3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan tugas tenagamedis.
- 4) Melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga medis.
- 5) Melakukan audit medik.
- 6) Melakukan pembinaan terhadap tenaga medic yang melakukan pelanggaran disiplin profesi.
- 7) Melakukan advokasi kepada tenaga medis yang diduga terkait penanganan kasus hukum pelayanan medis.

b. Tanggung Jawab

- 1) Melakukan koordinasi dengan Bidang Hukum, Rekam Medis, Bidang Keperawatan dan unit kerja yang terkait.
- 2) Melakukan pengumpulan data/informasi baik dari informasi langsung maupun melalui dokumen.
- 3) Memfasilitasi pertemuan multi disiplin untuk peninjauan kasus dengan melibatkan organisasi profesi dan bagian/bidang hukum.
- 4) Melakukan analisis terhadap sengketa medis yang terjadi.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Direktur dalam penyelesaian kasus dan upaya-upaya pencegahan kasus serupa dikemudian hari.

BAB III

TATA LAKSANA PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN

3.1 Penanganan Pengaduan Pelayanan Pada Jam Kerja

A. Menerima pengaduan

Unit kerja terkait menerima pengaduan dari pasien.

B. Mengelola pengaduan

Unit kerja dan Customer Service yang menerima pengaduan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencatat dan mengkaji informasi
 - a. Identitas dan kondisi pasien
 - b. Peristiwa
 - c. Tuntutan pasien
 2. Menanggapi pengaduan
 - a. Mengucapkan terima kasih atas laporan.
 - b. Memberikan penjelasan sementara kepada pasien dan berusaha untuk menenangkannya.
 - c. Menjamin keluhan akan ditindaklanjuti.
 - d. Laporkan pengaduan kepada atasan/karu apabila pasien tidak puas dengan jawaban petugas pada hari itu juga.
 - e. Laporkan kepada customer service apabila pasien tidak puas dengan jawaban atasan/karu, untuk disampaikan ke manajemen pada hari itu juga.
 - f. Customer service akan menyampaikan kepada manajemen dan pihak yang terkait atas pengaduan tersebut dan meminta jawabannya pada hari itu juga.
 - g. Pengaduan yang bersifat medis, akan disampaikan kepada dokter medical information yang dimana akan di rapatkan di komite medik (jika perlu) untuk memberikan jawaban dan penjelasannya berdasarkan standar Rumah Sakit Prima Husada.
 - h. Pengaduan yang tidak bersifat medis, akan diatasi oleh Customer service dengan pihak yang terkait berdasarkan standar Rumah Sakit Prima Husada paling lambat 2x24jam.
 - i. Jika jawaban sudah diterima oleh customer service, customer service akan menyampaikan jawabannya kepada pasien secara langsung (yang sifatnya nonmedis), dan ditemani oleh medical information (yang sifatnya medis) sebagai jawaban resmi dari pihak manajemen. Dalam menyampaikan jawaban, customer service mengundang pasien / keluarga secara kekeluargaan yang bertempat di ruang tamu lantai dasar.
 - j. Bila pasien tidak puas dengan jawaban manajemen, Customer Service akan melaporkan ke Customer Service Manager untuk mengatasi permasalahannya.
 3. Customer Service Manager melaporkan pengaduan ke Direktur RS
 - a. Memberi pertimbangan
 - b. Meminta pengarahan tindak lanjut
 4. Menindaklanjuti instruksi Direktur
- ##### C. Investigasi Kasus
1. Membahas kebenaran informasi tentang:
 - a. Identitas pasien

- b. Peristiwa
- c. Rekam medis (khusus pengaduan pelayanan medis)
- 2. Penataan dokumen (khusus pengaduan pelayanan medis) yang meliputi:
 - a. Dokumentasi informasi
 - b. Berkas rekam medis (medical record)
 - c. Dokumen persetujuan tindakan medis
 - d. Dokumen persetujuan tindakan medis tertentu (operasi)
 - e. Second opinion
 - f. Resume medis
 - g. Pendapat organisasi profesi
 - h. Keputusan MKEK / MDTK / MKDKI
 - i. Juklak, Juknis dan SPO Pelayanan
- 3. Mengadakan rapat dengan bagian terkait
- 4. Rapat dengan Komite Medis (khusus pengaduan pelayanan medis)
 - a. Pertimbangan aspek medis
 - b. Pertimbangan aspek manajemen
 - c. Pertimbangan aspek medicolegal
- 5. Pendapat Komite Etik Rumah Sakit

D. Analisa Kasus

1. Hasil rapat koordinasi menentukan atau memilah kategori kasus dan selanjutnya menugaskan unit terkait untuk menindaklanjuti:
 - a. Kasus Etik ditangani oleh MKEK/MDTK/MKDK/KERS
 - b. Kasus Administrasi ditangani oleh Customer Service
 - c. Kasus Hukum ditangani oleh Bagian/Bidang Hukum
 - d. Kasus Gabungan ditangani oleh Bagian/Bidang Hukum
2. Telaahan Kasus

Masing-masing unit diatas menyusun telaahan kasus. Didalam menelaah kasus, hal-hal yang perlu diperhatikan:

 - a. Kebenaran identitas pasien
 - b. Kebenaran peristiwa
 - c. Pertimbangan prosedur tindak lanjut
3. Masing-masing unit dimaksud melaporkan hasil telaahan disertai rekomendasi kepada manajemen.

E. Tindak lanjut penanganan kasus

1. Pendalaman kasus:
 - a. Pendapat manajemen rumah sakit
 - b. Pendapat Komite Medis (khusus pengaduan pelayanan medis)
 - c. Pendapat konsultan hukum (apabila diperlukan)
2. Penyimpulan posisi kasus ditinjau dari:
 - a. Kewenangan dan kompetensi
 - b. Indikasi dan kontra indikasi (khusus pengaduan pelayanan medis)
 - c. Persetujuan tindakan medic / *informed consent*
 - d. Kesesuaian tindakan dengan SPO
 - e. Hukum dan Perundang-undangan

3. Putusan manajemen tentang pilihan penyelesaian kasus
 - 1) Apabila dari hasil pendalaman disimpulkan bahwa secara hukum posisi rumah sakit/staf cukup kuat maka penyelesaian yang dipilih adalah litigasi. Terhadap tuntutan ganti rugi yang lebih kecil dari pada prediksi biaya penyelesaian dapat dipertimbangkan penyelesaian non litigasi (ADR)
 - 2) Apabila hasil pendalaman disimpulkan bahwa secara hukum, posisi rumah sakit / staf tidak cukup kuat maka penyelesaian yang dipilih adalah non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi).

F. Penyelesaian kasus

Dalam hal penyelesaian kasus melalui litigasi maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Menunjuk Kuasa Hukum/Penasehat Hukum
2. Menunjuk Staf Bidang / Bagian Hukum sebagai mitra kerja

Dalam hal penyelesaian kasus non litigasi ditempuh:

1. Pihak rumah sakit (manajemen) mengundang pihak pengadu untuk membicarakan penyelesaian kasus secara damai (negosiasi). Dipertemukannya pihak pengadu dengan pertimbangan secara matang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bila upaya negosiasi tidak berhasil maka ditunjuk salah satu orang/badan yang disepakati bersama dan mampu untuk bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus.
3. Hasil perdamaian melalui negosiasi dan mediasi dituangkan dalam suatu perjanjian yang sah secara hukum, bila perlu dikuatkan oleh Notaris atau didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

G. Dokumentasi Kasus

1. Seluruh dokumen yang terkait dengan kasus ditata dan diklarifikasi dengan pengkodean khusus.
2. Dokumen disimpan di Direksi/Wakil Direksi Pelayanan Medik sampai kasus dianggap selesai.
3. Bila kasus telah selesai dokumen dapat dikembalikan ke bagian yang menangani dokumen

H. Penyelesaian Tuntutan Hukum (tergantung kasus)

1. Diselesaikan dengan proses Perdata, Pidana atau Tata Usaha Negara.
2. Tuntutan harus dianalisa terlebih dahulu

Mekanisme pelaksanaan penanganan kasus hukum pelayanan medis perlu dilaksanakan dengan tahapan yang meliputi:

1. Pengumpulan Informasi dan Bukti

Informasi tentang adanya dugaan terjadi kasus hukum pelayanan medis di rumah sakit, biasanya bersumber dari media massa baik cetak maupun elektronik atau dari keluhan pasien (keluarga) baik langsung maupun yang disampaikan melalui kotak saran yang disediakan oleh rumah sakit. Selain itu pengaduan lembaga swadaya pasien dan keluarga atau kuasa hukum pasien dapat pula menjadi sumber informasi adanya dugaan kasus hukum pelayanan medis. Atas dasar hal itu maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

 - a. Informasi awal dihimpun oleh Unit Customer Service
 - b. Laporan ke Direksi oleh Customer Service Manager
 - c. Instruksi/Disposisi dari Direksi kepada Komite Medik dan Bag. Hukum
 - d. Komite Medik dan Bagian Hukum melaksanakan Instruksi / Disposisi Direksi.

- e. Komite Medik bersama Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan unit terkait di Rumah Sakit (melengkapi data / dokumen)
- f. Menentukan strategi penanganan kasus:
 - 1) Memilah kasus:
 - 3) Kasus etik,
 - 4) Kasus hukum (pidana, perdata, administrasi/disiplin)
 - 5) Kasus gabungan etik dan hukum
 - 2) Melakukan analisa kasus
 - 3) Menetapkan langkah penanganan
- g. Meminimalisasi dampak negatif dari pemberitaan (pelaksananya adalah Customer Service Manager) sesuai dengan SPO.
- h. Melakukan upaya pendekatan kepada keluarga untuk menjelaskan posisi kasus (pelaksananya adalah dokter ruangan didampingi oleh Customer Service Manager)
- i. Apabila penjelasan tidak dapat diterima oleh keluarga pasien, maka langkah selanjutnya:
 - 1) Merespon langkah yang dilakukan oleh keluarga pasien/kuasa hukum sesuai dengan tuntutan yang akan dilakukan.
 - 2) Bila tuntutan dilakukan melalui litigasi maka dilakukan langkah persiapan litigasi sesuai dengan SPO.
- j. Bila ada kesepakatan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, maka kasus diselesaikan secara damai.
- k. Setelah ada kesepakatan perdamaian, segera membuat Akta Perdamaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Alat Bukti Kasus Hukum Pelayanan Medis

Dalam kasus hukum pelayanan medis diperlukan bukti, yaitu:

- a. Dokumen informasi kasus medis dari media massa, kotak saran, dll.
- b. Berkas rekam medis:
 - 1) Catatan medis pasien
 - 2) Catatan keperawatan pasien
 - 3) Dokumen persetujuan tindakan medis
 - 4) Dokumen persetujuan tindakan medis tertentu (operasi)
 - 5) Second opinion
 - 6) Resume medis
 - 7) Pendapat organisasi profesi
 - 8) Keputusan MKEK/MDTK/MKDKI
 - 9) Juklak, juknis dan SPO Pelayanan

3. Mekanisme Penanganan di Rumah Sakit

Apabila telah terjadi penanganan kasus hukum pelayanan medis, maka yang diberitugas dan wewenang untuk menangani penanganan kasus hukum pelayanan medis adalah Komite Medik dan Bagian Hukum.

Komite Medik dan Bagian Hukum selanjutnya segera mengambil langkah-langkah dengan mengumpulkan dan mempelajari secara seksama informasi yang berkaitan dengan dugaan adanya penanganan kasus hukum pelayanan medis.

Komite Medik dan Bagian Hukum mempelajari dan menelaah informasi kasus hukum pelayanan medis yang disampaikan oleh pasien, keluarga, LSM ataupun kuasa hukum baik lisan maupun tertulis.

Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan pencatatan meliputi:

- a. Identitas pasien
 - 1) Nama pasien

-
- 2) Nama orang tua pasien
 - 3) Umur pasien
 - 4) Jenis kelamin pasien
 - 5) Alamat pasien
 - b. Ringkasan kejadian kasus
 - 1) Kronologis kasus
 - 2) Petugas yang terkait
 - 3) Waktu terjadinya
 - 4) Tindakan yang dilakukan
 - 5) Rencana/penanganan selanjutnya
 - c. Kondisi fisik pasien
 - 1) Meninggal dunia
 - 2) Cacat berat atau ringan
 - 3) Luka berat atau ringan
 - 4) Keracunan obat atau makanan
 - 5) Patah tulang
 - 6) Perbuatan tidak menyenangkan
 - 7) Lain-lain
 - d. Pengaduan/Tuntutan Pasien/Keluarga
 - a. Laporan
 - b. Somasi
 - c. Tuntutan: Perdata, Pidana dan Administrasi
 - d. Lain-lain

Selanjutnya Bagian Hukum melapor kepada Direksi Rumah Sakit perihal adanya tuntutan pasien dan atas arahan Direksi, Bagian Hukum mengundang rapat koordinasi satuan kerja terkait yaitu Komite Medik, Komite Keperawatan, Bagian Rekam Medik dan unit kerja lain untuk ikut membahas penanganan kasus hukumpelayanan medis dari berbagai aspek.

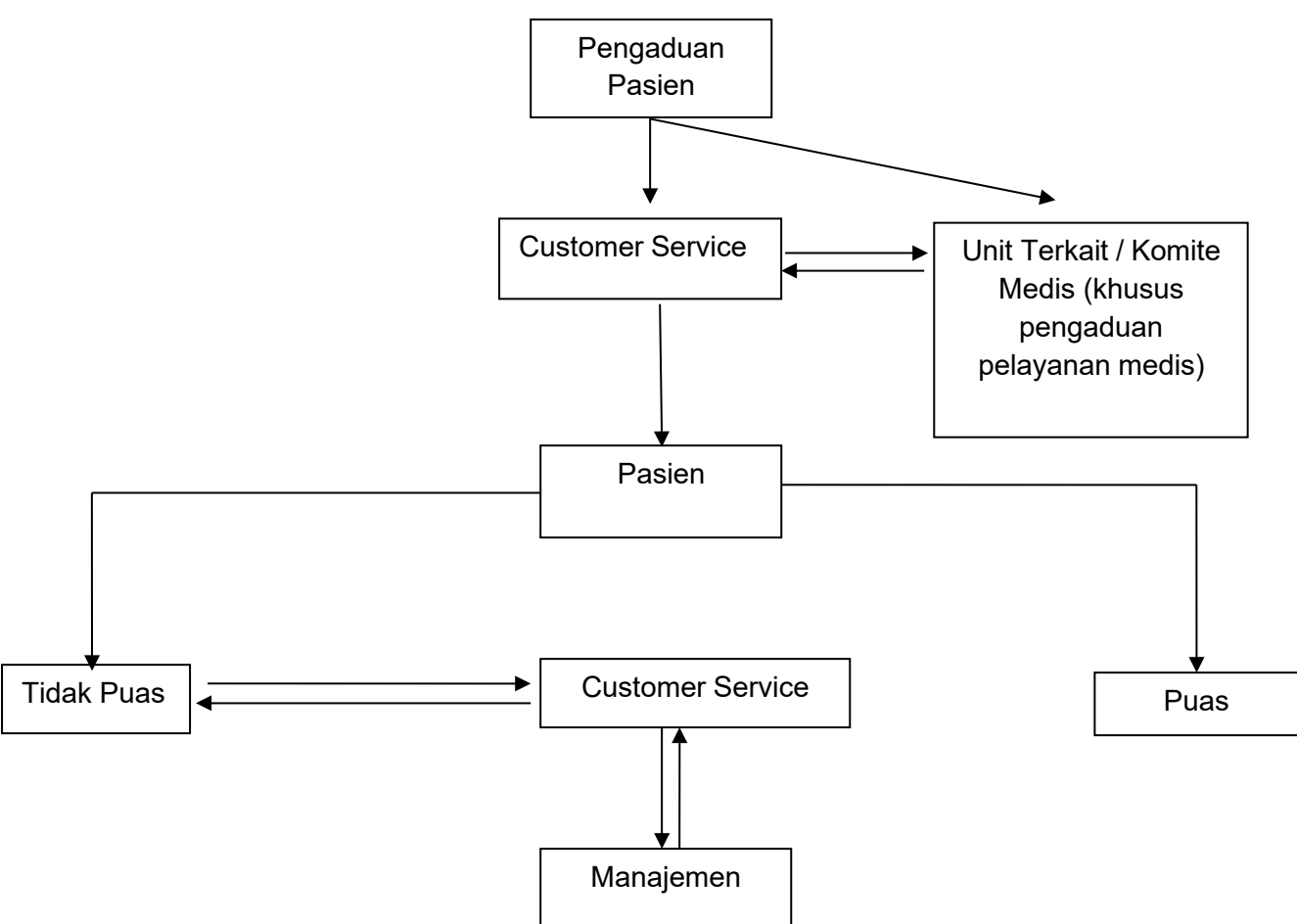
Rapat pembahasan kasus medis bersifat tertutup, terbatas, rahasia dan jadwal rapat pelaksanaan tersebut harus dilaporkan secara tertulis kepada Direksi Rumah Sakit. Saat rapat koordinasi pembahasan penanganan kasus hukum pelayanan medis, masing-masing peserta rapat harus membawa bukti-bukti yang terkait dengan penanganan kasus tersebut.

Dalam rapat pembahasan kasus, hal-hal yang harus dibicarakan antara lain:

- 1) Kebenaran identitas pasien
- 2) Kebenaran peristiwa yang disampaikan pasien
- 3) Aspek hukum yang berkaitan dengan doktrin tentang kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
- 4) Malpraktik medis
- 5) Etika kedokteran
- 6) Status kepegawaian, surat izin praktik dan surat pengesahan dari Departemen Kesehatan bagi dokter yang menangani
- 7) Indikasi medis
- 8) Persetujuan tindakan medis
- 9) Catatan medis dan catatan keperawatan apakah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) Kehati-hatian penanganan sesuai SPO.
- 11) Penerapan juklak dan juknis sarana dan prasarana pelayanan
- 12) Tuntutan pasien

Apabila dalam rapat pertama belum dapat diambil kesimpulan dan langkah- langkah penanganan yang diperlukan, bahkan bila dipandang perlu untuk diadakan pendalaman lebih lanjut, maka pembahasan kasus hukum pelayanan medis dapat dilanjutkan pada waktu lain yang disepakati oleh seluruh peserta rapat.

Setiap kali rapat pembahasan kasus, harus dibuatkan daftar hadir peserta rapat dan risalah rapat dengan klasifikasi rahasia yang disampaikan secara terbatas hanya pada peserta rapat dan Direksi rumah sakit.



Gambar 3. 1 Alur Proses Penanganan Pengaduan Pada Jam Kerja

3.2 Penanganan Pengaduan Pelayanan Diluar Jam Kerja

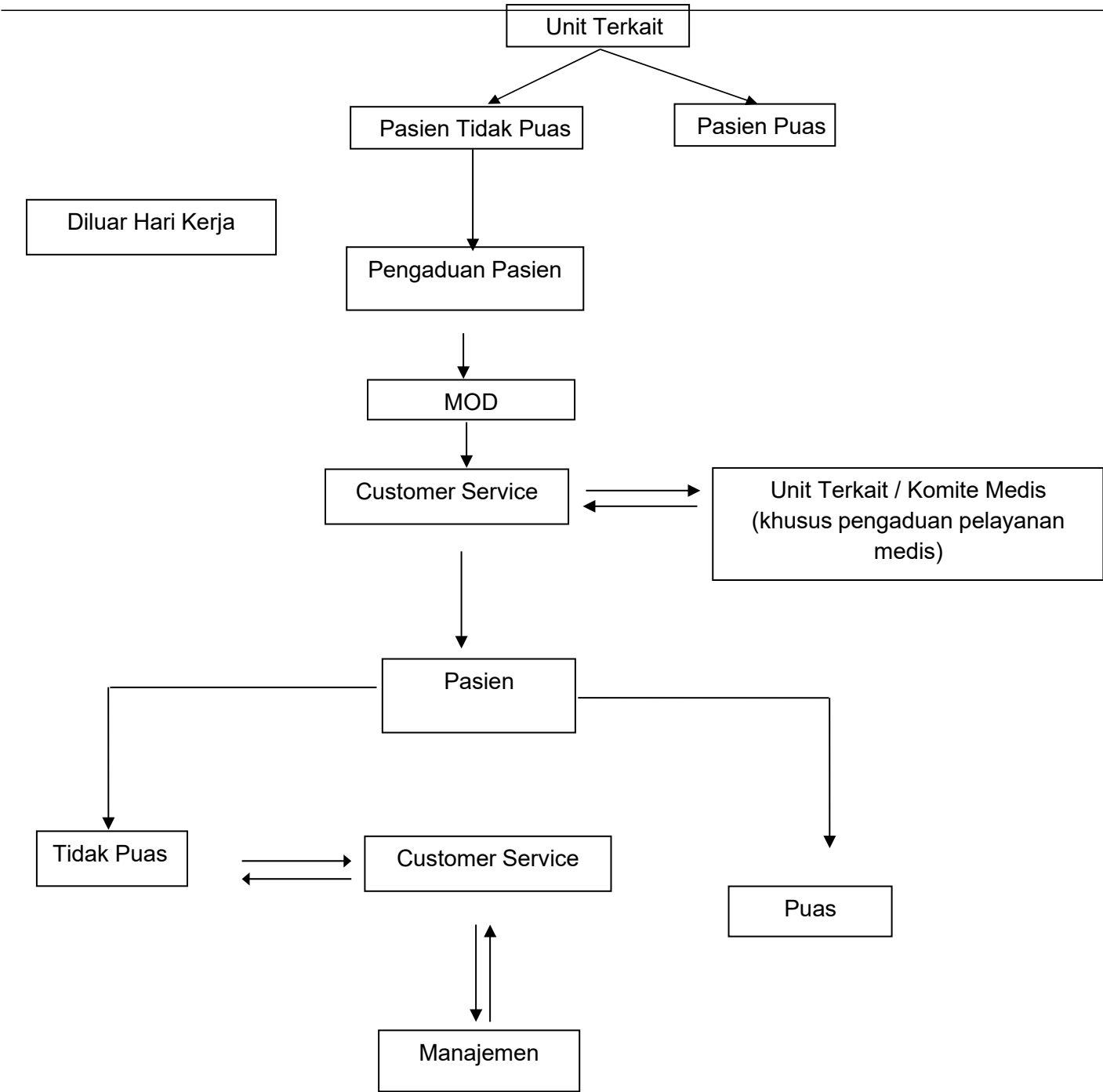
A. Menerima pengaduan

Unit kerja terkait menerima pengaduan dari pasien.

B. Mengelola pengaduan

Unit kerja yang menerima pengaduan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencatat dan mengkaji informasi
 - a. Identitas dan kondisi pasien
 - b. Peristiwa
 - c. Tuntutan pasien
2. Menanggapi pengaduan
 - a. Mengucapkan terima kasih atas laporan.
 - b. Memberikan penjelasan sementara kepada pasien dan berusaha untuk menenangkannya.
 - c. Menjamin keluhan akan ditindaklanjuti.
 - d. Laporkan pengaduan kepada On Duty (MOD) apabila pasien tidak puas dengan jawaban petugas pada hari itu juga.
 - e. Bila pasien tidak puas dengan jawaban Manajer On Duty (MOD), maka minta pasien untuk mengisi formulir pengaduan untuk disampaikan ke manajemen.
 - f. Manajer On Duty (MOD) memberikan formulir pengaduan tersebut kepada customer service untuk ditindaklanjuti keesokan harinya.
 - g. Customer service akan menyampaikan kepada manajemen dan pihak yang terkait atas pengaduan tersebut dan meminta jawabannya.
 - h. Pengaduan yang bersifat medis, akan disampaikan kepada dokter medical information dimana akan di rapatkan di komite medik (jika perlu) untuk memberikan jawaban dan penjelasannya berdasarkan standar Rumah Sakit Prima Husada.
 - i. Pengaduan yang tidak bersifat medis, akan diatasi oleh Customer service dengan pihak yang terkait berdasarkan standar Rumah Sakit Prima Husada 24x24jam.
 - j. Jika jawaban sudah diterima oleh customer service, customer service akan menyampaikan jawabannya kepada pasien secara langsung (yang sifatnya non medis), dan ditemani oleh medical information (yang sifatnya medis) sebagai jawaban resmi dari pihak manajemen. Dalam menyampaikan jawaban, customer service mengundang pasien / keluarga secara kekeluargaan yang bertempat di ruang tamu lantai dasar.
 - k. Bila pasien tidak puas dengan jawaban manajemen, Customer Service akan melaporkan ke Customer Service Manager untuk mengatasi permasalahan



Gambar 3.2 Alur Proses Penanganan Pengaduan Di Luar Jam Kerja

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pasien dan Keluarga ini dapat dijadikan acuan oleh Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan dalam menangani pengaduan pasien meliputi penelahaan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, sehingga diharapkan dapat dilakukan penanganan pengaduan pasien dan keluarga secara cepat, cermat dan berkualitas.

Langkah selanjutnya adalah mendorong Pimpinan Instansi/Unit Kerja untuk menindaklanjuti pengaduan pasien dan keluarga guna memperbaiki mutu pelayanan di unit kerjanya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 04 April 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah